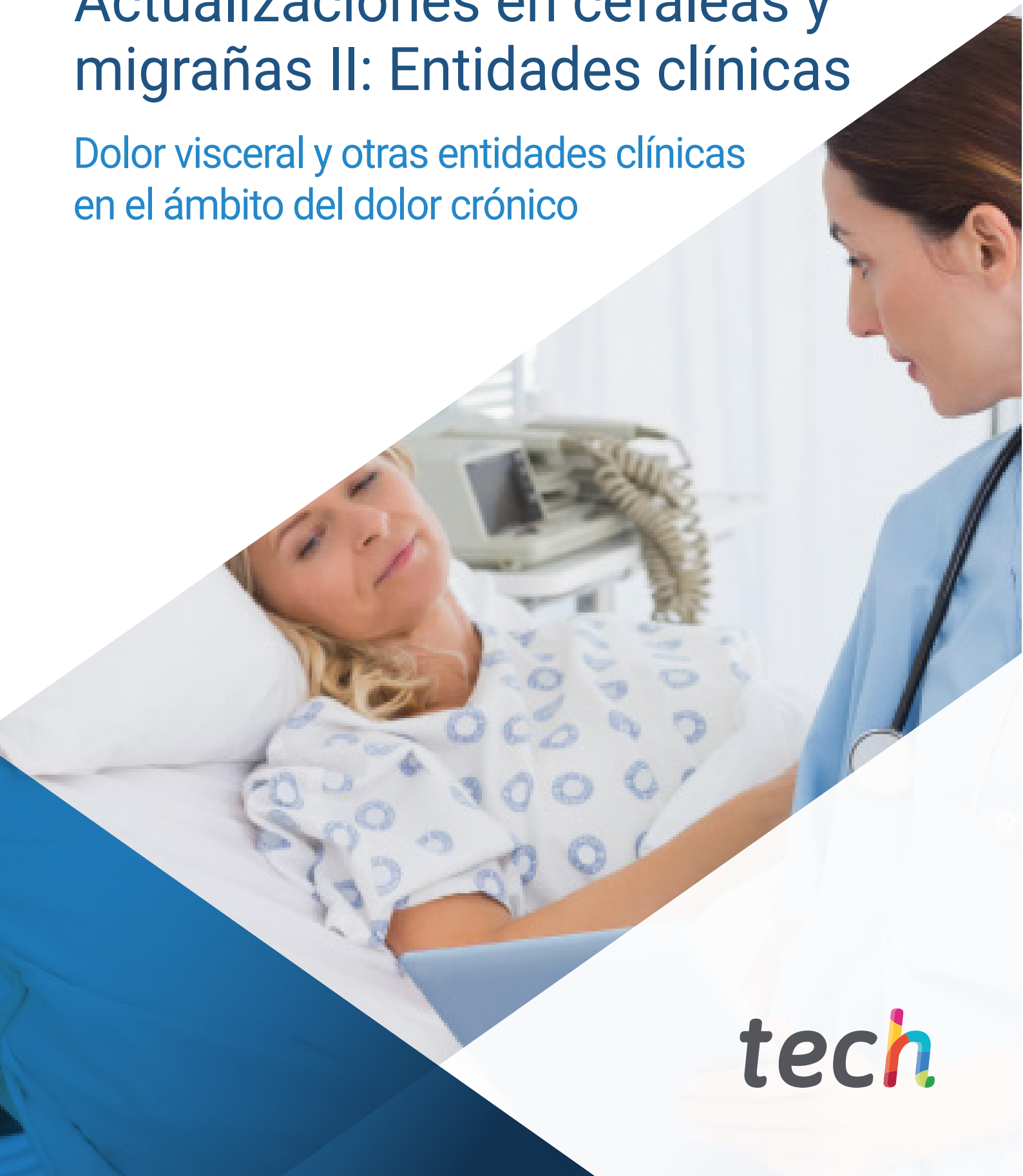
Actualizaciones en cefaleas y migrañas II: Entidades clínicas

Dolor visceral y otras entidades clínicas en el ámbito del dolor crónico



tech

CONTENIDO

1. Objetivos

2. Introducción

3. Migraña: tratamiento sintomático y preventivo

Tratamiento de las crisis agudas.
Crisis leves-moderadas.
Crisis moderadas-severas.
Crisis muy graves.
Tratamiento preventivo.
Tratamiento médico.

4 Cefalea tensional

Tratamiento no farmacológico.
Tratamiento farmacológico sintomático.
Tratamiento preventivo.

5. Cefalea en racimos

Tratamiento sintomático.

6. Bibliografía

Objetivos

Los objetivos de este tema son: el conocimiento del enfoque y manejo de tratamiento las cefaleas seleccionadas, dada su prevalencia e importancia. Dentro del abordaje farmacológico, se ha realizado una actualización del nivel de evidencia de los principales fármacos utilizados que el alumno deberá conocer.

Introducción

El tratamiento de las cefaleas se debe plantear sobre una base de actuación individualizada, identificando los factores responsables y desencadenantes en cada tipo de cefalea. Este planteamiento se fundamenta en medidas farmacológicas y no farmacológicas con la máxima eficacia clínica probada, la menor comorbilidad asociada y que ocasionan los mínimos efectos adversos.

Para aliviar el dolor existe una amplia gama de medicamentos. El tratamiento más adecuado dependerá de las características del dolor, su frecuencia e intensidad.

El tratamiento comenzará por educar al paciente sobre la enfermedad para evitar los factores desencadenantes, planteando como primer objetivo disminuir los episodios de dolor. Después, se establece una estrategia terapéutica con el fin de abortar estos episodios y reducir la intensidad del dolor y los síntomas acompañantes.

Migraña: tratamiento sintomático y preventivo

El tratamiento de la migraña engloba tres aspectos: tratamiento de las crisis agudas, tratamiento preventivo, manejo de los factores cronificadores (29).

Tratamiento de las crisis agudas

En el abordaje del tratamiento sintomático de una crisis de migraña se deben tener en cuenta los principales síntomas de la misma (dolor, alteración vegetativa y alteración afectiva) y actuar sobre todos y cada uno de ellos. Los fármacos para el tratamiento de la migraña pueden dividirse en: no específicos, específicos y coadyuvantes.

Entre los no específicos están los analgésicos comunes y los AINE, que se emplean sobre todo en cefaleas leves y moderadas. Los tratamientos específicos son los ergóticos y los antagonistas de los receptores 5-HT1B/D o triptanes. Se usan en cefaleas moderadas y severas. Los tratamientos coadyuvantes son antieméticos (domperidona, metoclopramida) y ansiolíticos (diazepam). El tratamiento debe ser individualizado, para cada paciente y para cada crisis migrañosa.

Crisis leves-moderadas

Los analgésicos comunes (Paracetamol y AAS) tienen poca utilidad, limitándose su uso a la migraña de la infancia y la adolescencia. Es importante evitar combinaciones de analgésicos con barbitúricos, codeína y/o cafeína, ya que producen habituación y riesgo de producir una cefalea crónica diaria por abuso de analgésicos. El metamizol, es un fármaco muy usado en el país, que se ha mostrado eficaz pero del cual no existen estudios consistentes.

Los pacientes con crisis moderadas pueden ser tratados al inicio con AINE en combinación con un antiemético. Los AINE que más eficacia han demostrado son: el naproxeno sódico, ibuprofeno y desketoprofeno trometamol. Sus frecuentes efectos adversos digestivos constituyen un factor limitante de su uso. En pacientes que no respondan o tengan intolerancia a los AINE estaría indicado comenzar con triptanes.

Aquellos pacientes que precisen diez o más tomas de fármacos sintomáticos en un mes, han de ser tratados obligatoriamente con agentes preventivos para evitar la cefalea crónica por abuso de analgésicos.

Crisis moderadas-severas

Los ergóticos son los fármacos específicos que más se usan en crisis moderadas-severas. Actúan sobre los mismos receptores que los triptanes: 5-HTB/D, responsables del control migrañoso. Sin embargo, tienen importantes efectos adversos: náuseas y vómitos, calambres musculares, adormecimiento y dolor muscular en extremidades. Más preocupantes son sus efectos cardiovasculares, ya que inducen una vasoconstricción no selectiva, que puede producir angor e isquemia de miembros inferiores. Su uso crónico, sobre todo si se asocia a cafeína, puede inducir cefalea de rebote y desencadenar una cefalea crónica diaria por abuso de ergotamina. También hay efectos adversos asociados a su uso crónico.

Actualmente los ergóticos solo estarían indicados en pacientes que los hayan usando largo tiempo con buena respuesta y que tengan una baja frecuencia de crisis (no más de 1 por semana).

Los triptanes constituyen el tratamiento de elección en las crisis de migraña moderadas-severas. A diferencia de los ergóticos también mejoran las manifestaciones vegetativas. Actualmente hay varios triptanes comercializados en el país que se diferencian sobre todo por su farmacocinética y sus presentaciones. Hay preparados para uso por liotabs, nasal y subcutáneo. Su eficacia aumenta claramente si se usan precozmente en el inicio de la crisis, cuando el dolor es aún leve. Los triptanes no modifican el aura migrañosa.

Crisis muy graves

En pacientes con falta de respuesta o intolerancia se puede usar el sumatriptan subcutáneo. En caso de persistir la falta de respuesta se puede recurrir al ketorolaco o el desketoprofeno trometamol por vía IM o IV asociado o no a metoclopramida o domperidona. En caso de que el dolor continúe, más de 72 horas, está indicada la metilprednisolona a dosis de 80 mg/12-24 horas.

Tratamiento preventivo

El tratamiento preventivo está encaminado a reducir la frecuencia y la intensidad de las crisis, a mejorar la respuesta al tratamiento agudo, a disminuir la incapacidad del paciente y a mejorar su calidad de vida. También ayuda a impedir el abuso de analgésicos, el cual contribuye a trasformar la migraña en crónica, dificultando seriamente su tratamiento.

Se considera efectivo cuando reduce a la mitad la frecuencia de las crisis en un periodo de 3 meses, y esto sucede en algo más de la mitad de los pacientes. Es importante tener en cuenta que son necesarias 2 o 3 semanas para que aparezca el efecto completo, y poder determinar si una medida terapéutica es efectiva o no *(Tabla 1)*.

Tratamiento médico

- **Betabloqueantes:** la dosis mínima ha de alcanzarse de forma paulatina, en un plazo de 15 a 20 días. Es posible incrementarla gradualmente hasta la dosis máxima si no hay respuesta. Están indicados como primera elección en el tratamiento preventivo de pacientes con episodios de migraña con aura y sin aura, y son especialmente adecuados cuando se asocian síntomas de ansiedad o estrés en pacientes hipertensos y en migrañosos que, además, presenten temblor esencial o hipertiroidismo.

  Están contraindicados en casos de insuficiencia cardiaca, bloqueo aurículo-ventricular de segundo o tercer grado, y en broncopatías espásticas. El 20 % presenta efectos secundarios: fatiga, frialdad de extremidades, síntomas gastrointestinales y sensación de mareo.

- **Neuromoduladores (antiepilépticos):** son los fármacos de elección para el tratamiento de la migraña con aura (nivel de evidencia: I, grado de recomendación: A).

  Topiramato y valproato sódico son los dos fármacos neuromoduladores más útiles como preventivos de la migraña. Se utilizan en las migrañas con y sin aura, en el aura migrañosa sin cefalea y en la migraña con aura de tronco. Desde hace algún tiempo se está utilizando con éxito lamotrigina como tratamiento preventivo del aura migrañosa prolongada. También hay alguna evidencia con gabapentina y, por ahora en menor medida, con levetiracetam y zonisamida. Podría plantearse la zonisamida en pacientes que no toleren el topiramato.

- **Antidepresivos:** constituyen una segunda línea de tratamiento preventivo de la migraña. Su principal indicación es en aquellos pacientes con migraña y cefalea tensional, o en los que coexisten depresión o ansiedad. El fármaco de elección es la amitriptilina.

  En algunos casos pueden ser útiles los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) por su mejor tolerabilidad (fluoxetina, sertralina y paroxetina), aunque su utilidad no ha sido demostrada.

  Los efectos secundarios de la amitriptilina son frecuentes: sedación, mareo, estreñimiento, incremento de peso, hipotensión ortostática, palpitaciones y dispepsia. Presenta las siguientes contraindicaciones: glaucoma, síndrome prostático, embarazo, lactancia y en aquellos que tomen inhibidores de la monoamino oxidasa (IMAO).

- **Calcioantagonistas:** el más empleado y eficaz es la flunarizina, el resto de calcioantagonistas no tienen eficacia considerable en la prevención de migraña. Los efectos adversos más frecuentes son: aumento de peso, somnolencia, depresión y raramente desarrollo de síndromes extrapiramidales.

- **AINE:** hay cuatro grandes indicaciones de estos fármacos en el tratamiento preventivo de la migraña:
  - Prevención de la migraña menstrual.
  - En pacientes con crisis graves y frecuentes de migraña mientras el tratamiento preventivo estándar comienza a hacer efecto.
  - En pacientes con migraña crónica y abuso de analgésicos.
  - En el tratamiento preventivo del infarto migrañoso.

- **Onabotulinumtoxina A:** ha demostrado eficacia para la profilaxis de la MC (nivel de evidencia: I, grado de recomendación: A), tras la publicación de los estudios PREEMPT *(Tabla 2)*.

  En España, onabotulinumtoxina A está aprobada desde el año 2012 como tratamiento preventivo de la MC en pacientes que no han respondido adecuadamente o son intolerantes a los medicamentos preventivos de la migraña.

Recomendaciones generales para todos los pacientes	Tratamiento preventivo adicional por:	Tratamiento individualizado con base en:
• Modificaciones de estilo de vida. • Prevención de factores desencadenantes. • Evitar los factores de riesgo modificables y cronificadores.	• La frecuencia de los ataques de migraña. • El grado de discapacidad que provoca. • Las preferencias del paciente.	• Evidencia de la eficacia. • Perfil de eventos adversos secundarios. • Interacciones medicamentosas. • Comorbilidad. • Costo. • Preferencias del paciente.

Tabla 1.

Fármaco	Dosis	Nivel de evidencia y grado de recomendación	Observaciones
Topiramato	50-200 mg/día	100 mg/día (recomendada)	I A
Onabotulinumtoxina A.	1,55 U, en 31 puntos cada 3 más o meses según respuesta	I A	Puede administrarse 40 U adicionales en los grupos musculares occipital, temporal y trapecio.
Valproato sódico	500 mg/12 horas.	II B	
Levetiracetam	250-500 mg/12horas.	II B	
Propranolol	Dosis media 160 mg/día.	II B	No ha demostrado eficacia y no se recomienda la combinación con topiramato en MC.
Amitriptilina	25-50 mg/día.	III B	
Candesartán	16 mg/día.	II B	
Pregabalina	75 o más mg/día.	IV C	
Zonisamida	100 – 200 mg/día.	IV C	
Flunarizina	5 mg/día.	IV C	

Tabla 2.

Cefalea tensional

Tratamiento no farmacológico

El tratamiento no farmacológico se considera primordial. Se debe dedicar tiempo en atender, escuchar e informar al paciente de la benignidad subyacente tranquilizándolo al respecto. Hay que buscar la corrección de factores desencadenantes y agravantes identificados en la anamnesis, como estrés físico o emocional, normas que corrijan posturas anómalas mantenidas durante el trabajo, el sueño, fatiga, etc. La actividad física suave, que ejercite los músculos craneocervicales y de cintura escapular, se recomienda por ser beneficiosa (nivel de evidencia: I; grado de recomendación: A).

La terapia cognitiva-conductual mediante psicólogos terapeutas para el control del estrés y el manejo de la percepción del dolor (nivel de evidencia: IV; grado de recomendación: C).

La fisioterapia manual multimodal (consistente en manipulación articular, sobre tejidos blandos, técnicas de relajación miofascial, etc.) posee estudios (nivel de evidencia: I; grado de recomendación: A) que muestran mayor beneficio, comparado con tratamiento farmacológico a corto plazo, en reducir la frecuencia, intensidad y duración de la cefalea tensional.

La acupuntura, practicada en centros acreditados, en un metaanálisis de la Cochrane ha mostrado ser efectiva en la cefalea tensional, tanto episódica como crónica.

Tratamiento farmacológico sintomático

Los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) y analgésicos simples tienen bien definida su efectividad moderada en los cuadros episódicos, con un 30 % libre de dolor a las dos horas. En cambio, es muy limitado su beneficio en los estados crónicos. Se recomienda dosis única y repetir a las dos horas si se precisa. Los fármacos estudiados son el ácido acetilsalicílico (500-1000 mg), ibuprofeno (400 mg) y paracetamol (1000 mg) con eficacia demostrada; en cambio, el ketoprofeno (25 mg) muestra muy ligera eficacia comparado con placebo, eficacia que muy probablemente sea superada por los efectos adversos. De ellos, el que presenta menor efecto es el paracetamol. Se recomienda evitar el sobreuso de fármacos, así como la utilización de combinaciones (por el riesgo de abuso de medicación que estas preparaciones conllevan). No existe evidencia que indique el uso de inhibidores de la ciclooxigenasa tipo 2. En los pocos estudios controlados realizados con bloqueos del nervio occipital mayor no se ha demostrado beneficio y no se recomienda su uso. Igualmente están desaconsejados los opiáceos (como tramadol o codeína) por su tendencia a propiciar al sobreuso y cronificación.

Tratamiento preventivo

Los fármacos que tienen indicación de primera línea con estudios que así lo demuestran son los antidepresivos amitriptilina y mirtazapina (nivel de evidencia: I, grado de recomendación: A). Amitriptilina es el fármaco con mayor evidencia de todos los preventivos. La dosis recomendada de inicio es de 10 o 12,5 mg diarios en toma nocturna, con incrementos semanales hasta una dosis comprendida entre 25 y 75 mg diarios *(Figura 1).*

Cefalea en racimos

Tratamiento sintomático

Triptanes

- **Sumatriptán subcutáneo:** es el fármaco más efectivo en el tratamiento de las crisis, administrado a dosis de 6 mg, actuando en los primeros 15 minutos (aunque normalmente hace efecto en los primeros minutos). La dosis diaria máxima recomendada es de dos inyecciones de 6 mg. La formulación intranasal de 20 mg de sumatriptán es menos efectiva y tiene un inicio de acción más lento que el preparado inyectable, siendo efectivo en los primeros 30 minutos.
- **Zolmitriptán:** se administra por vía intranasal y a dosis de 10 mg. Su efectividad es comparable a sumatriptán intranasal, con efecto en unos 30 minutos en el 50 % de los pacientes.
- **Triptanes orales:** aunque se ha probado su eficacia, la forma oral no debería ser utilizada ya que el efecto se retrasa mucho más que con las formas subcutáneas e intranasales.

  Los triptanes están contraindicados en pacientes con patología vascular: cardiopatía isquémica, vasculopatía cerebral o periférica e hipertensión arterial mal controlada (nivel de evidencia: IV; grado de recomendación: C). Los efectos secundarios suelen ser opresión torácica y cervical, parestesias, molestias en el área de inyección, fatiga y decaimiento de causa no aclarada pero que lleva a rechazar la medicación.

Oxígeno

Dos tercios de los pacientes con cefalea en racimos responden a la inhalación de oxígeno al 100 %, una característica única en las cefaleas primarias. Su eficacia ha sido probada en muchos estudios, incluyendo un ensayo aleatorizado controlado con placebo. Se administra a alto flujo, con mascarilla, a unos 12-15 litros por minuto (lpm), en posición sentada. El efecto comienza a los 15-20 minutos y, si hay respuesta, el ataque es totalmente controlado. La ventaja es su falta de efectos secundarios y la posibilidad de repetirlo tantas veces como sea necesario. El oxígeno puro está contraindicado en la insuficiencia cardiaca o respiratoria.

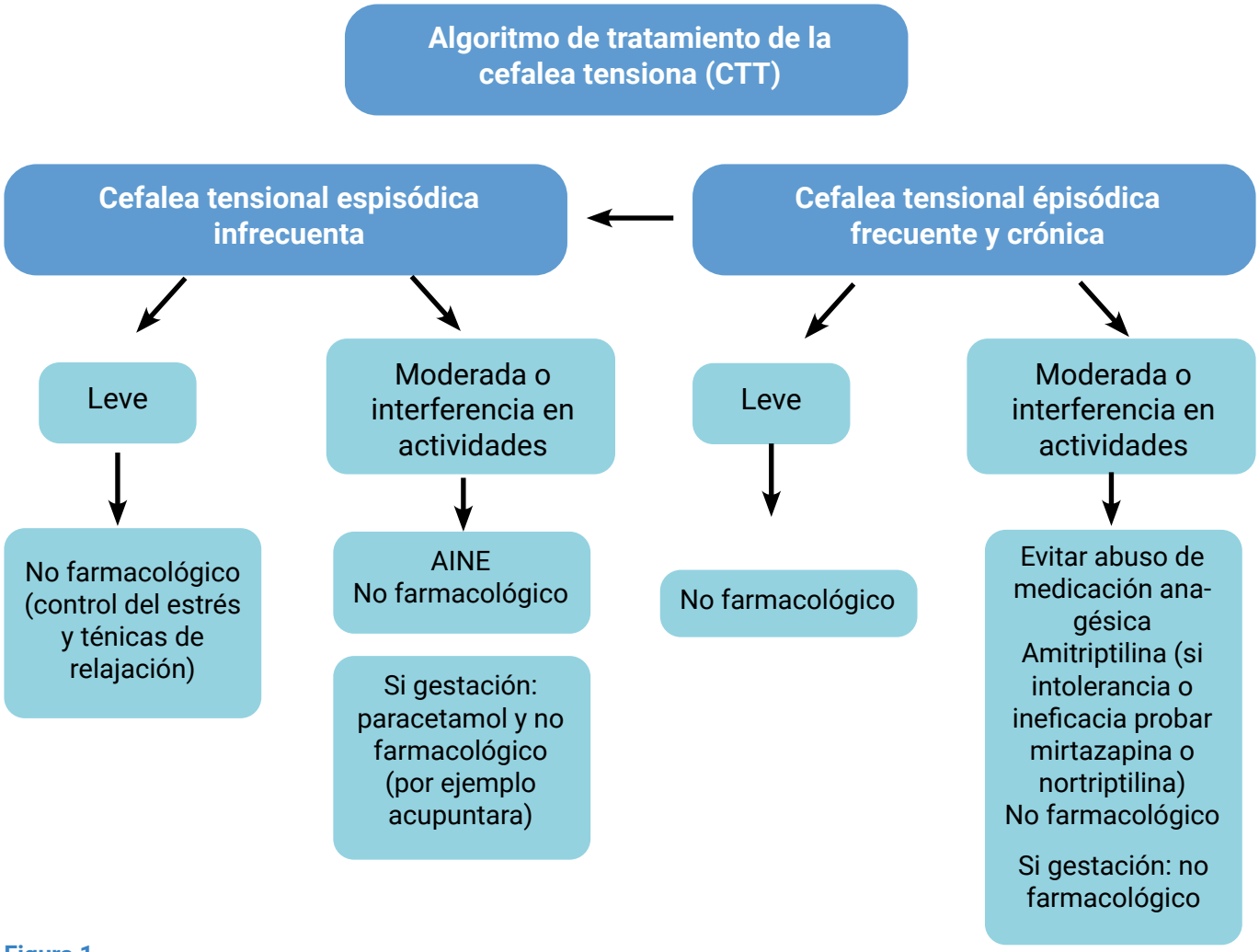


Figura 1.

Lidocaína

La lidocaína es efectiva para detener las crisis de cefalea en racimos en un tercio de los pacientes. Debe considerarse en pacientes sin respuesta a oxígeno y en los que los triptanes sean inefectivos o estén contraindicados. Se administra en forma de gotas o en aerosol en la fosa nasal ipsilateral al dolor. La dosis recomendada es de 1 ml (al 4-10 %). El efecto es rápido (10 minutos) pero la eficacia es moderada y, por tanto, debe usarse como terapia adyuvante. El fármaco debe instilarse con el paciente en decúbito, con la cabeza hacia abajo y rotada hacia el lado sintomático. Tras la aplicación, la posición debe mantenerse durante al menos 5 minutos.

Bibliografía

1. Domínguez C, Vieites-Prado A, Pérez-Mato M, Sobrino T, Rodríguez-Osorio X, López A, et al. Role of adipocytokines in the pathophysiology of migraine: A cross-sectional study. Cephalalgia. 2018;38(5):904-911.
2. Su M, Yu S. Chronic migraine: A process of dysmodulation and sensitization. Mol Pain. 2018;14:1-10.
3. Bigal ME, Lipton RB. The differential diagnosis of chronic daily headaches: an algorithm-based approach. J Headache Pain. 2007;8(5):263-72.
4. Lipton RB, Silberstein SD. Episodic and chronic migraine headache: breaking down barriers to optimal treatment and prevention. Headache. 2015;55 (2):103-22.
5. Guerrero AL, Diaz-Insa S, Lopez-Mesonero L, Oterino DuránA, Irimia P. Guías diagnósticas y terapéuticas de la Sociedad Española de Neurología. En: Ezpeleta D, Pozo-Rosich P, editores. Guía oficial de práctica clínica en cefaleas. Madrid: Editorial Luzán 5; 2015. p. 89-104.

6. Bigal ME, Lipton RB. Concepts and mechanisms of migraine chronification. Headache. 2008;48(1):7-15. 29.
7. Deneris A, Rosati Allen P, Hart Hayes E, Latendresse G. Migraines in women: current evidence for management of episodic and chronic migraines. J Midwifery Womens Health. 2017;62(3):270-85.
8. Becker WJ. Acute migraine treatment in adults. Headache. 2015;55(6):778-93.
9. Pringsheim T, Davenport WJ, Marmura MJ, Schwedt TJ, Silberstein S. How to apply the AHS evidence assessment of the acute treatment of migraine in adults to your patient with migraine. Headache. 2016;56(7):1194-200.
10. MedWatch, U.S. Food & Drug Administration. https://www.fda.gov/safety/medwatch-fda-safety-information-and-adverse-event-reporting-program/medical-product-safety-information. Accessed April 3, 2017.
11. Giamberardino MA, Mitsikostas DD, Martelletti P. Update on medication-overuse headache and its treatment. Curr Treat Options Neurol. 2015;17(8):368.
12. Schwedt TJ. Preventive therapy of migraine. Continuum (Minneap Minn). 2018;24(4):1052-65.